HOSPITAL REGIONAL de MONIQUIRÁ E.S.E.

Crecemos para cuidar tu Salud!

CONEXIÓN CLÍNICA

Crecemos en Saber

RUTA INSTITUCIONAL

PROTOCOLO ATENCIÓN DE PACIENTE AGREDIDO POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA

1 PACIENTE INGRESA A URGENCIAS



Consulta por:

- Mordedura
- Arañazo
- Lamedura
- Contacto con mucosas
- Contacto con murciélagos
- Contacto con animal potencialmente transmisor de rabia

2 INTERROGATORIO OBLIGATORIO

El médico debe interrogar y documentar:

Sobre el accidente

- ✓ Fecha y hora de la exposición
- ✓ Tipo de exposición:
  - Mordedura
  - Arañazo
  - Lamedura
  - Contacto con mucosas
- ✓ Número de lesiones
- ✓ Profundidad
- ✓ Localización anatómica
- ✓ Sangrado presente o ausente

Sobre el animal

- ✓ Especie
- ✓ Propietario identificado
- ✓ Estado vacunal
- ✓ Observable por 10 días
- ✓ Animal vivo o muerto
- ✓ Signos compatibles con rabia
- ✓ Callejero o silvestre

3 CLASIFICAR LA EXPOSICIÓN Y CONDUCTAS ESPECÍFICAS

CATEGORÍA I NO EXPOSICIÓN

Lavado exhaustivo de la lesión durante 10 a 15 minutos, con agua y jabón que esté a la mano.

Valorar indicación de manejo antibiótico y/o antitetánica.

CONDUCTAS

Diligenciar ficha de notificación SIVIGILA 300* de manera inmediata para garantizar observación del animal; en caso de pérdida, muerte o presencia de signos de rabia reclasificar exposición.

Incluye:

- ✓ Animal observable
- ✓ Vacunado
- ✓ Sin signos de rabia

CATEGORÍA II EXPOSICIÓN LEVE

Lavado exhaustivo de la lesión durante 10 a 15 minutos, con agua y jabón que esté a la mano.

Valorar indicación de manejo antibiótico y/o antitetánica.

Iniciar esquema de vacunación antirrábica: Cuatro dosis de 0,5 mL o 1 mL según la presentación. (0, 3, 7, 14).

CONDUCTAS

- Diligenciar ficha de notificación SIVIGILA 300.
- Iniciar esquema de vacunación antirrábica: Cuatro dosis de 0,5 mL o 1 mL según la presentación (0, 3, 7, 14).

Incluye:

- ✓ Mordedura superficial
- ✓ Arañazo superficial
- ✓ Lamedura en piel lesionada
- ✓ Animal no observable

CATEGORÍA III EXPOSICIÓN GRAVE

Lavado exhaustivo de la lesión durante 10 a 15 minutos, con agua y jabón que esté a la mano.

Valorar indicación de manejo antibiótico y/o antitetánica.

CONDUCTAS

- Diligenciar y notificar de manera inmediata ficha de notificación **SIVIGILA 300.**
- Iniciar esquema de vacunación antirrábica: Cuatro dosis de 0,5 mL o 1 mL según la presentación (0, 3, 7, 14).
- Aplicar **inmunoglobulina antirrábica*** según indicación (**ver paso 4**).

Incluye:

- ✓ Mordedura profunda
- ✓ Múltiples lesiones
- ✓ Lesiones en: cabeza, cara, cuello, dedos y genitales
- ✓ Contacto con murciélagos
- ✓ Animales silvestres
- ✓ Contacto con animal sospechoso de rabia

4 INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA

Aplicar cuando exista EXPOSICIÓN GRAVE (Categoría III)

- ✓ Infiltrar la mayor cantidad posible alrededor de las heridas.
- ✓ El resto aplicar IM (NO en glúteos).
- ✓ No aplicar por vía intravenosa.

Dosis recomendadas:

Inmunoglobulina Humana (HRIG):	Inmunoglobulina Equina Purificada (ERIG):
20 UI/kg de peso	40 UI/kg de peso

Aplicar lo antes posible, preferiblemente junto con la primera dosis de la vacuna antirrábica.

5 NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

SIVIGILA 300

- Diligenciar ficha SIVIGILA 300.
- Notificación inmediata.
- Coordinar observación del animal por 10 días.
- Registrar y hacer seguimiento del caso.

Observación del animal por 10 dias

Si el animal presenta signos compatibles con rabia durante este periodo o muere, el caso se reclasifica como exposición grave.

RECORDATORIOS CLAVE

- Todo contacto con murciélagos, lesiones en cabeza, cara, cuello, dedos y genitales, múltiples lesiones o contacto con animales silvestres = considerar exposición grave.
- En pacientes inmunocomprometidos el manejo debe ser oportuno y completo.
- Nunca retrasar la vacunación si existe indicación.

*** Nota:**
Respecto al máximo de centímetros en la aplicación por infiltración, no se tiene un estándar de volumen debido a que depende de la localización de la lesión, el grado de afectación y la capacidad del área afectada, toda vez que se debe evitar sobrepresión y eventuales síndromes compartimentales.